MASOTERAPIA I

Semana 08

MASAJES - PRACTICA

Docente
Lic. Gilmer Emilio Malca C.

Presente.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

¿Cuáles son las características del masaje?

Presente.

- **VIDEO DEMOSTRATIVO: Observar el video.**

https://www.youtube.com/watch?v=2KWkSjjG_y4

- **OBSERVE LA IMAGEN:**

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

- **LOGRO:**

- Que alumno identifique los principales técnicas usadas en la zona cervical así como estiramientos.

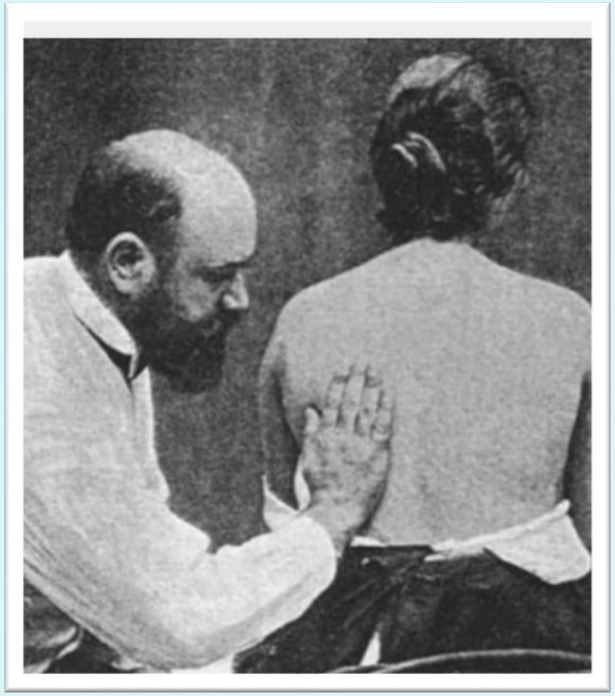
MASAJE TERAPÉUTICO

Historia del masaje

Puede considerarse como uno de los medios terapeuticos mas antiguos utilizados por el hombre. Literatura China del 2700 a.C y en la hindu 2000 años antes de nuestra era.

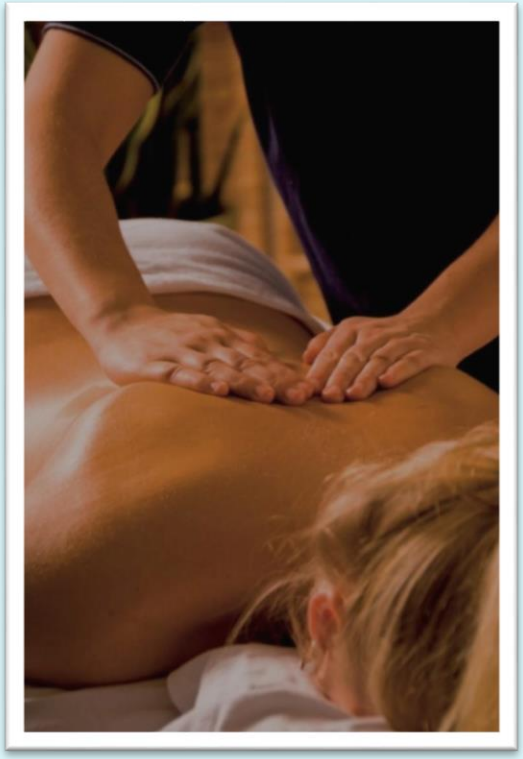
- Massien (amasar) Griego
- Mass (tocar, palpar) Arabe
- Acheht (tantear) Hebreo

Hipocrates (Efecto y contraindicaciones)
Galeno (129 -199 d.C)
Edad media
Siglo XIX el sueco Heling (1776- 1839) Fundador de las tec.
Holandés Meztger (1839-1909)
Siglo XX Hoffa (1859- 1907)
Mennel (1880- 1957)



MASAJE TERAPÉUTICO

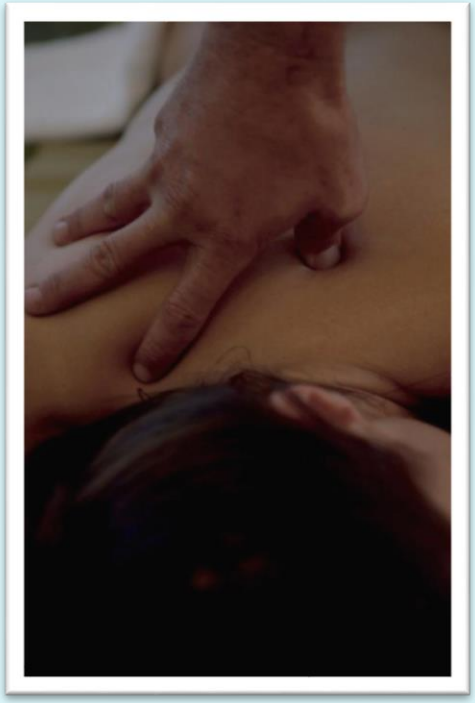
Es un método manual o instrumental que mediante mecanismos directos o reflejos, modifican el estado de los tejidos subyacentes al área orgánica tratada, además de producir una beneficiosa repercusión sobre el estado general del paciente.



EFECTOS Y REACCIÓN FISIOLÓGICA

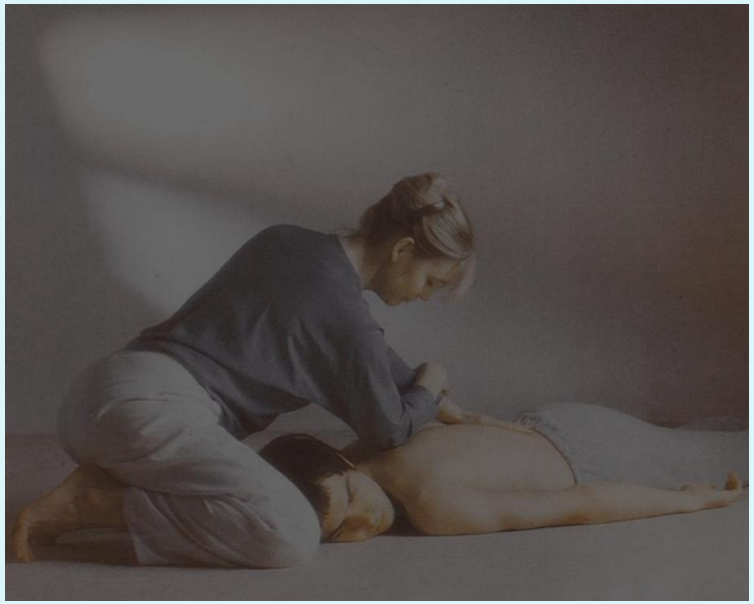
- Acción refleja: Se produce cuando el masaje ejercido sobre la piel es suave y deslizante prácticamente no va acompañado de presión alguna, por lo que no va unida a un efecto mecánico.

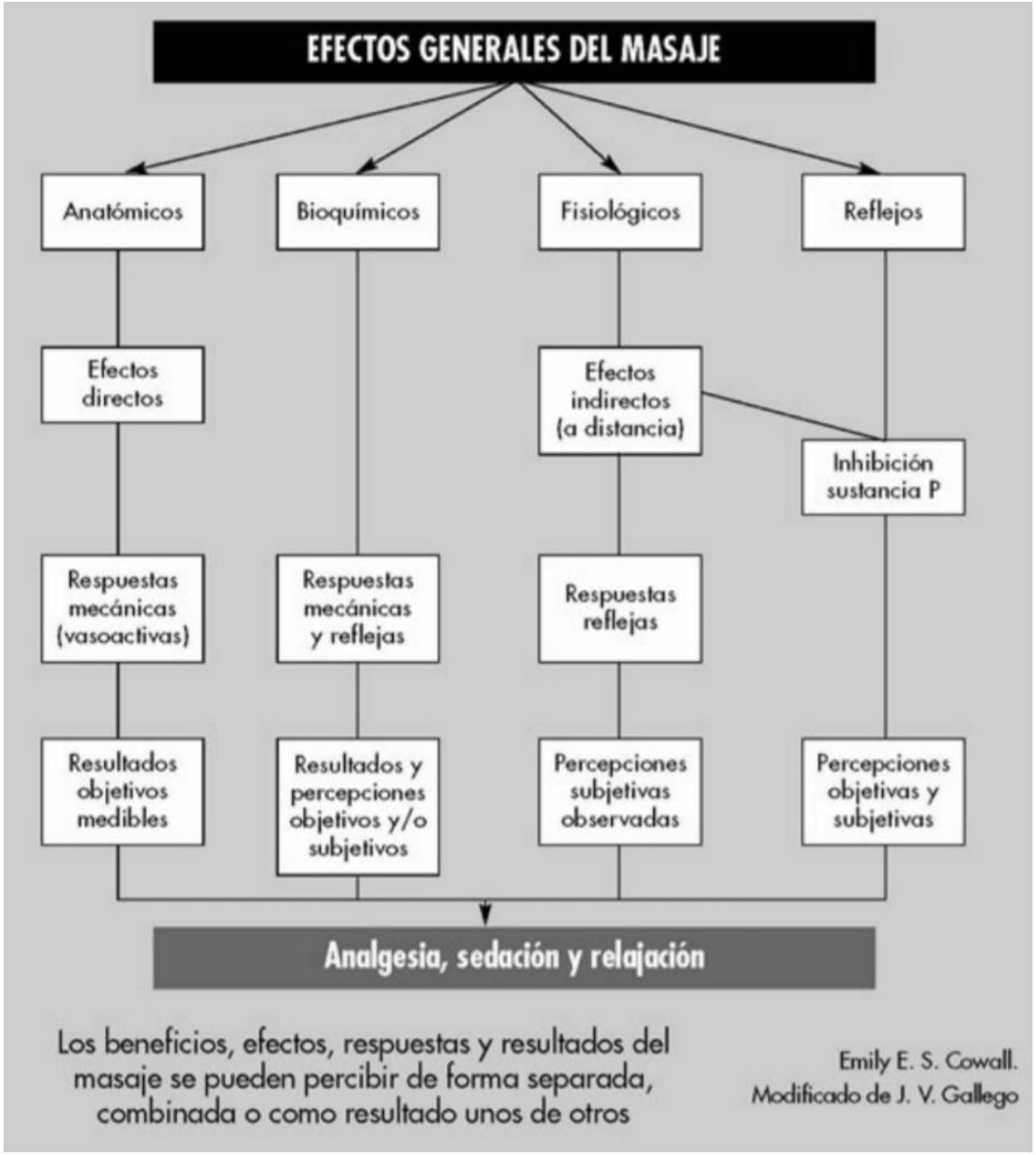
- Acción mecánica: Se produce como consecuencia de las presiones ejercidas sobre los tejidos.



EFECTOS Y REACCIÓN FISIOLÓGICA

- Acción sobre la circulación sanguínea y linfática
- Acción sobre la piel
- Acción sobre el sistema neuromuscular




EFECTOS GENERALES DEL MASAJE
Anatómicos
Bioquímicos
Fisiológicos
Reflejos
Efectos directos
Efectos indirectos (a distancia)
Inhibición sustancia P
Respuestas mecánicas (vasoactivas)
Respuestas mecánicas y reflejas
Respuestas reflejas
Resultados objetivos medibles
Resultados y percepciones objetivos y/o subjetivos
Percepciones subjetivas observadas
Percepciones objetivas y subjetivas
Analgesia, sedación y relajación
Los beneficios, efectos, respuestas y resultados del masaje se pueden percibir de forma separada, combinada o como resultado unos de otros
Emily E. S. Cowall.
Modificado de J. V. Gallego

MANIOBRAS BÁSICAS

- Frotación o deslizamiento

- Fricción

- Vibración

- Entre otros, (trepidación, gelotripsia, pellizcamiento)

MASAJE SUECO

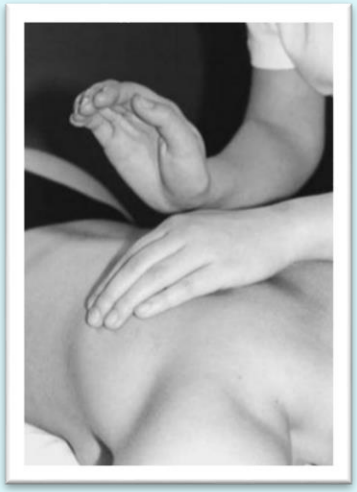
Es el masaje más común y extendido en el mundo occidental. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX dejo de ser masaje sueco para denominarlo, “Masaje Tradicional Europeo” o “Terapéutico”

El Prof. Sueco Per Henrik Ling (1776-1839)

“Gimnasia médica”

- Mov. Activos
- Mov. Asistidos y con resistencia
- Mov. Pasivos (movimiento y masaje)

MANIOBRAS BÁSICAS

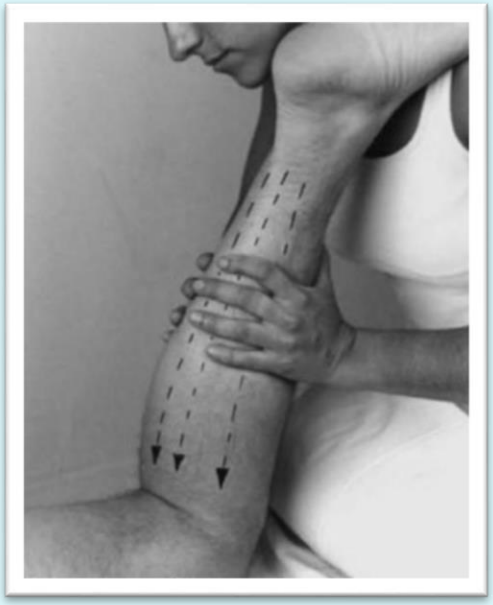


- **Effleurage**: Acarisiamiento (relajante)
- **Petrissage**: Amasamiento (disminuye y disgrega tejido adiposo)
- **Friction**: Fricción (ayuda a la penetración de los medicamentos)
- **Tapotement**: Percusión Y pellizcamiento (arrastra mejor las toxinas para mejorar el metabolismo)

MASAJE DEPORTIVO

Permite preparar al cuerpo para el esfuerzo que conllevan las prácticas deportivas o como terapéutica de las lesiones producidas por estas.

Permitiendo calentar los tejidos y preparando la musculatura a contraerse a su máxima intensidad.



- Fricción, presión y masajes profundos
- Técnicas superficiales y vibraciones
- Técnicas superficiales, presiones y fricciones suaves (progresivo de masaje profundo y pellizcamiento)

MASAJE TRANSVERSO PROFUNDO

Fue desarrollado por James Cyriax (1904 – 1985), médico ortopeda británico. Que con maniobras muy puntuales actúan sobre zonas muy limitadas: musculares, tendinosas, capsuloligamentosas.

Puede aplicarse en esguinces recientes, secuencias de distinción muscular y patologías tendinosas. Principalmente en afecciones crónicas inflamatorias.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

- Dolores musculares, tendinosos, periarticulares
- Neuralgias diversas
- Parálisis y contracturas
- Hemiplejia en fase espastica
- Insomnio
- Edemas
- Hematomas de pequeño tamaño
- Celulitis
- Cicatrices y adherencias
- Problemas musculares
- Transtornos tróficos o hemodinámicos arteriales

- Procesos inflamatorios agudos e infecciones agudas
- Flebitis agudas
- Tumores malignos
- Fx o traumatismo recientes
- Procesos reumáticos en fase evolutiva
- Procesos litiásicos
- Embarazos

INDICACIONES DEL MASAJE

GENERALES

- Hipotonía muscular, atrofia muscular
- Estasis arterial, arteritis, varices
- Dolores, contracturas y espasmos musculares
- Infiltrados subcutáneos, miogelosis, celulalgias
- Linfedema, insuficiencia venosa periférica
- Cicatrices dolorosas, adheridas y queloides
- Hematomas (según la fase en que se encuentren)
- Fibrositis (según la fase)
- Lesiones musculares del deporte (contusión, calambre)
- Rigideces articulares y periarticulares
- Algias articulares, con o sin algodistrofia
- Espondiloartrosis locales y generalizadas
- Cervicalgias, dorsalgias y lumbalgias
- Tortícolis aguda
- Cervicobraquialgia, lumbociatalgia y otras radiculopatías
- Tendinitis y adherencias tendinosas
- Entesalgias, entesitis, fascitis
- Esguinces y postinmovilización de los mismos
- Previo a manipulaciones vertebrales y periféricas
- Pre y post “stretching”
- Otros dolores de variada etiología (vascular, visceral)
- Paraplejía y tetraplejía (“nursing” de prevención de escaras)

CONTRAINDICACIONES DEL MASAJE EN REHABILITACIÓN

GENERALES

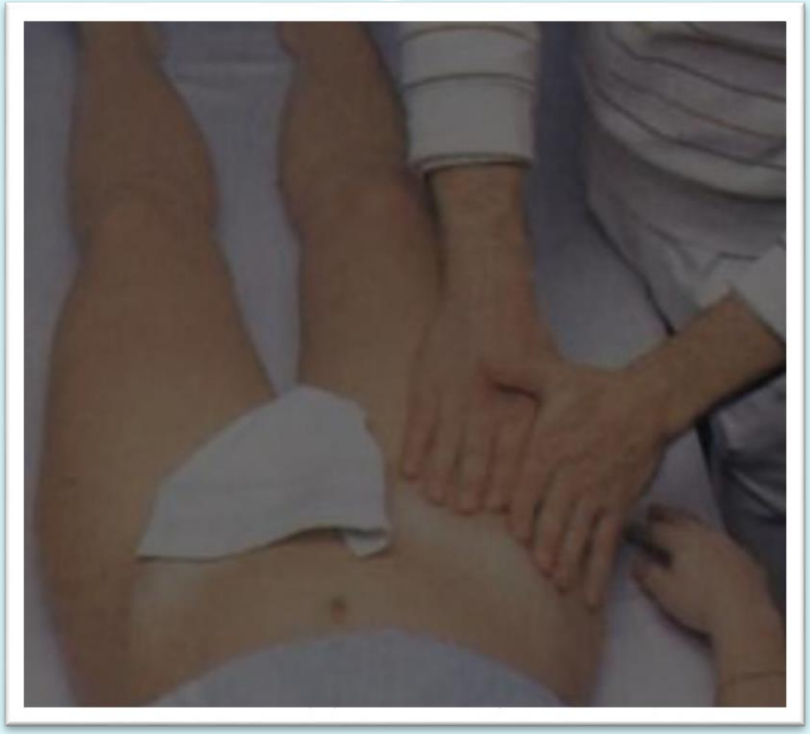
- Tromboflebitis
- Embolismo
- Cicatrices recientes y/o productivas
- Zonas anestésicas
- Infección y/o inflamación aguda
- Lesiones cutáneas
- Cardiopatías graves
- Neuropatías graves
- Diabetes descompensada
- Gota
- Diátesis hemorrágica, linfógena
- Neoplasias diversas

ESPECÍFICAS DEL APARATO LOCOMOTOR

- Hernia, desgarro o rotura musculares
- Rotura de vainas y/o tendones (total o parcial)
- Rotura reciente de ligamentos
- Heridas abiertas
- Hematomas recientes
- Hemorragia reciente

- Inflamación articular postraumática (con o sin sinovitis)
- Artritis aguda
- Calcificaciones: supraespinoso, hematoma calcificado, ligamento lateral interno de la rodilla
- Miositis osificante
- Fibrosis, tendinitis, entesitis (en fases agudas)
- Aumento del dolor o de la contractura muscular

DRENAJE LINFÁTICO

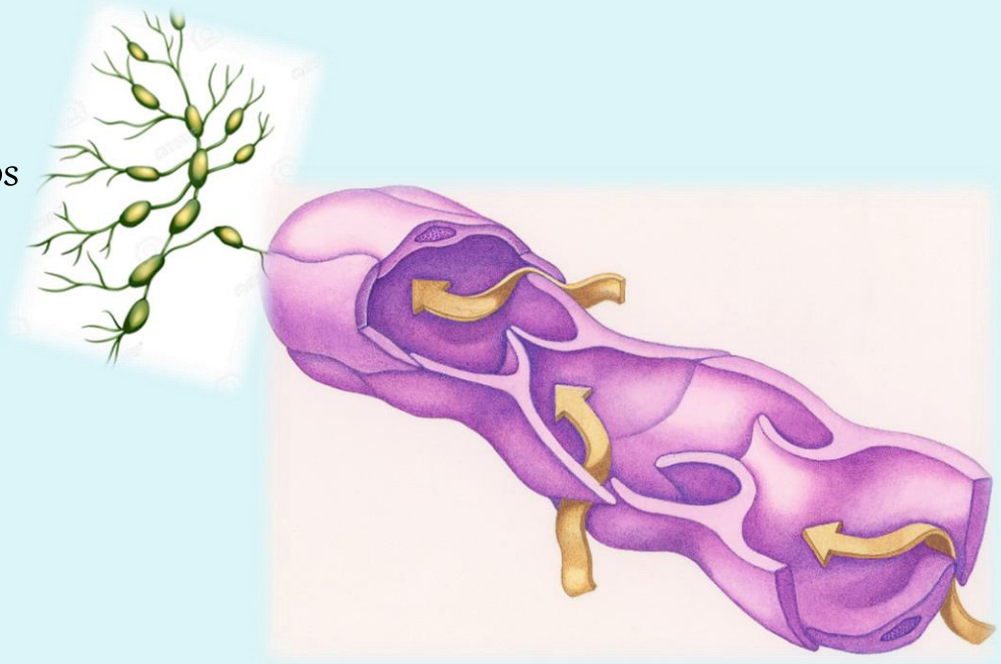


SISTEMA LINFÁTICO

IMPORTANTE

Conocer el recorrido del sistema

"los vasos sanguíneos siempre van acompañados de vasos linfáticos"



→ ¿Que es la linfa?

(no posee plaquetas, ni hematíes)

SLS y SLP

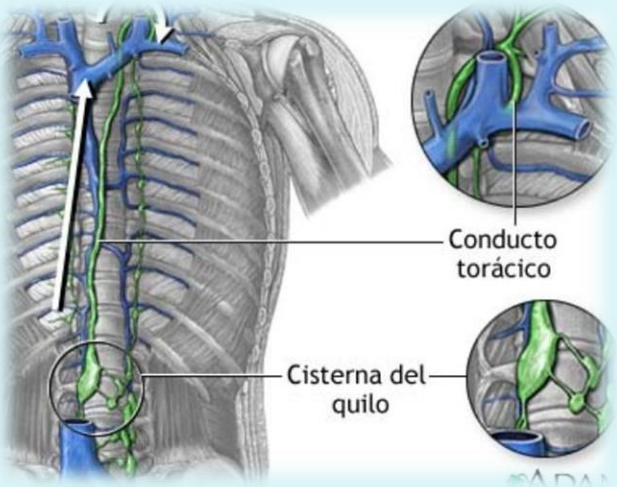
- Conductos linfáticos (canales prelinfáticos, capilares linfáticos y vasos linfáticos)
- Ganglios linfáticos

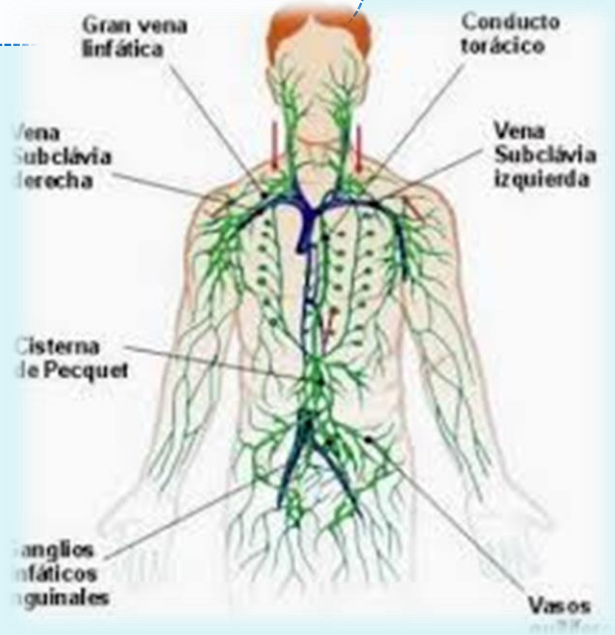
SISTEMA LINFÁTICO

VASOS LINFÁTICOS

(GRANDES COLECTORES)

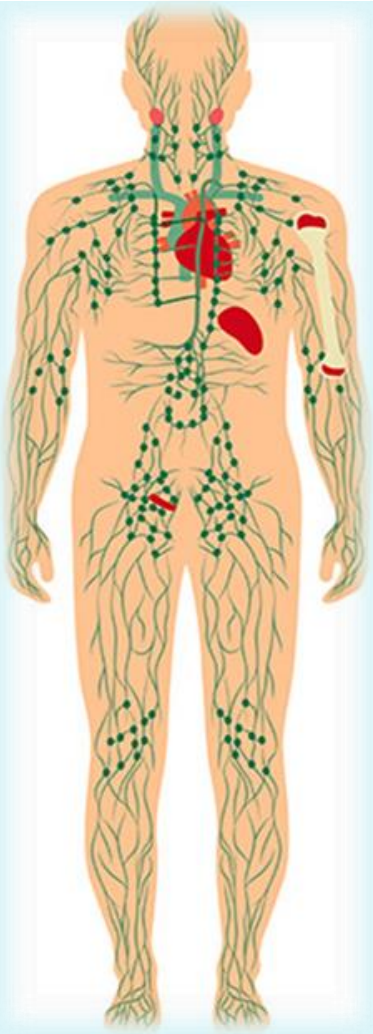
- ✓ Cisterna de pecquet o de kilo: Recoge la mitad inferior del cuerpo.
- ✓ Conducto torácico: Recoge la mitad inferior e izquierda del tórax, del MSI, la mitad de la cabeza y cuello.
- ✓ Gran vena linfática: Recoge la parte superior derecha, la mitad derecha de la cabeza y cuello y MS.





GANGLIOS PRINCIPALES

- Ganglio estellar
- Ganglio supraclavicular
- Ganglio axilar
- Ganglio torácico
- Ganglio abdominal (placa o cisterna de pecquet)
- Ganglio inguinal
- Ganglio poplíteo



DRENAJES LINFÁTICO

“Arrastre y Bombeo”

Tensión Tisular

DLM y DLMe

Objetivo Principal: **Disminuir el edema**

- Recomendado para Edemas de diferente origen.
- Actúa en el Sistema Vegetativo e Inmunológico.
- Combinarlo con US.

“Es MUY IMPORTANTE que el masaje lo realice un profesional fisioterapeuta o que este especializado en la técnica de drenaje linfático manual”.

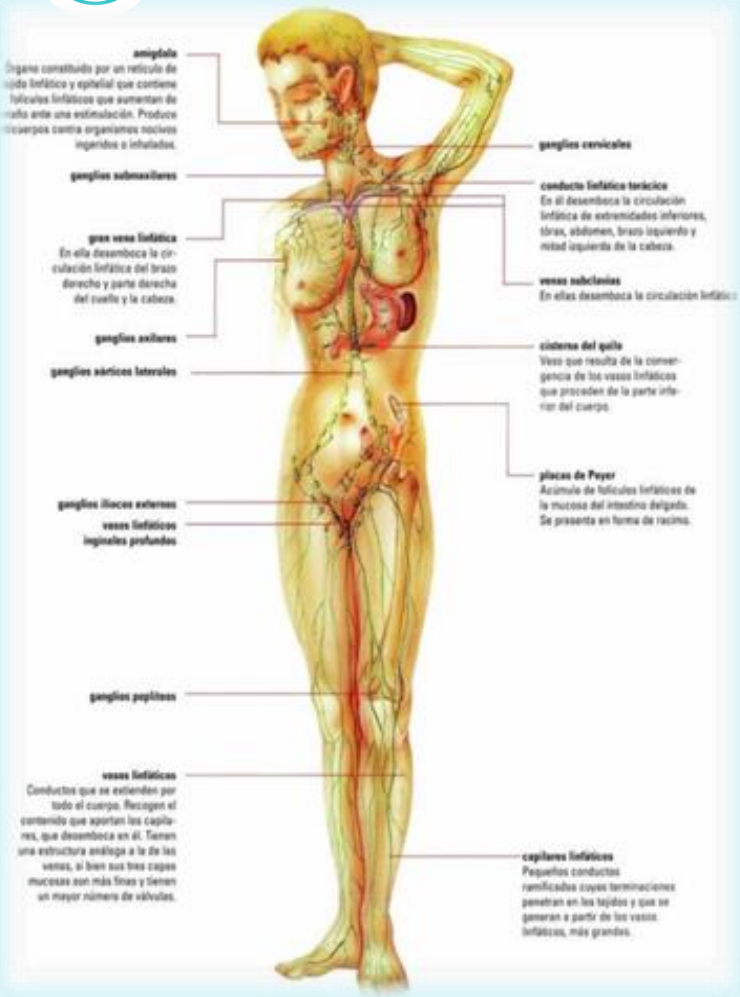
DRENAJE LINFATICO

- Paso 1: Inspección de ganglios.
- Paso 2: Palpación de ganglios.
- Paso 3: Apertura de ganglios.

En sentido a las agujas de reloj

- Paso 4: Arrastre.
- Paso 5: Bombeo.
- Paso 6: Cierre de ganglios.

En sentido contrario a las agujas de reloj



Beneficios del DLM

- Acelera y redirige la circulación linfática.
- Eliminar los restos de medicación, anestesia y suero utilizados en la operación.
- Favorecer la regeneración de los capilares y vasos linfáticos dañados tras la liposucción.
- Mejorar el estado de la piel.
- Acelerar la recuperación de los tejidos.
- Estimula el sistema Inmunológico.
- Favorecer la retracción de la piel.
- Depura el organismo.
- Baja la presión sanguínea.

DRENAJE LINFÁTICO

INDICACIONES	CONTRAINDICACIONES
Procesos postquirúrgicos	Cáncer o Tumoraciones malignas
Retenciones de líquidos	Insuficiencias cardiacas
Hematomas	Trombosis Infecciones agudas
Celulitis	Hipotensión Infecciones Cronicas
Problemas renales	Flebitis o tromboflebitis

- **Actividad para la clase**

- Formar un grupo de 5 integrantes colocarse en una camilla y poner en practica las técnicas visualizadas en clase.

- ¿Qué aprendimos hoy?
- ¿Qué dificultades tuvimos?
- ¿Para que nos sirve lo aprendido?

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

• CONSULTAS

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Fernández, A. (2015). Masoterapia. Técnicas y fundamentos. Editorial Médica Panamericana.Libro completo y actualizado sobre técnicas de masaje, indicaciones, contraindicaciones y fundamentos anatómicos.
- Sánchez, M. A., & Pérez, J. (2012). Masaje terapéutico: Principios y práctica. Editorial Elsevier España.Cubre tipos de masajes, patologías tratadas, y fundamentos fisiológicos.Castañer, M., & Camerino, O. (2001).
- Técnicas de masaje terapéutico y deportivo. Paidotribo.Enfocado en el ámbito deportivo, con descripciones prácticas de técnicas y aplicaciones.
- Beardsley, C. (2020). The Science and Practice of Manual Therapy. Churchill Livingstone.Muy citado en fisioterapia y masoterapia; cubre biomecánica, evidencia y práctica clínica.Benjamin, B., & Lamp, S. (2005).
- Understanding Sports Massage. Human Kinetics.Enfocado en el masaje deportivo y la recuperación muscular.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.